Kelainan Letak Janin setelah Usia Kehamilan 36 Minggu

Anandha Mardhia Prefitri
Departemen Obstetri dan Ginekologi
Universitas Hasanuddin



Tujuan pembelajaran

Setelah kuliah ini, mahasiswa mampu:

1. **Menjelaskan**
   definisi dan bentuk kelainan letak setelah 36 minggu
2. **Mengidentifikasi**
   faktor risiko ibu, janin, plasenta, dan ketuban
3. **Memeriksa dan mendiagnosis**
   dengan anamnesis, Leopold, dan USG
4. **Menjelaskan tatalaksana**
   termasuk versi luar, cara persalinan, dan rujukan

1

Konsep dasar

Istilah, bentuk kelainan letak, dan alasan 36 minggu menjadi titik keputusan

Empat istilah yang harus dibedakan

Letak (situs)

Hubungan sumbu panjang janin dengan sumbu panjang ibu: memanjang, lintang, atau oblik.

Presentasi

Bagian janin yang paling bawah di jalan lahir: kepala, bokong, atau bahu.

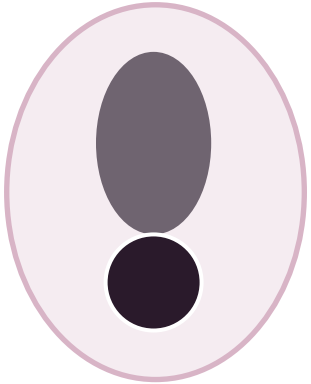
Posisi

Arah penunjuk (denominator) terhadap panggul ibu, misalnya sakrum kiri depan.

Sikap (habitus)

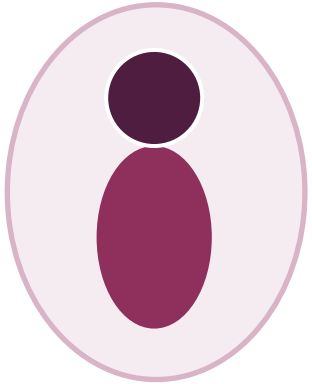
Hubungan bagian janin satu sama lain: fleksi, defleksi, atau ekstensi.

Bentuk kelainan letak



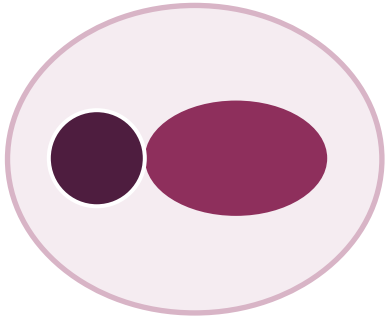
Presentasi kepala

Memanjang; kepala di bawah (normal)



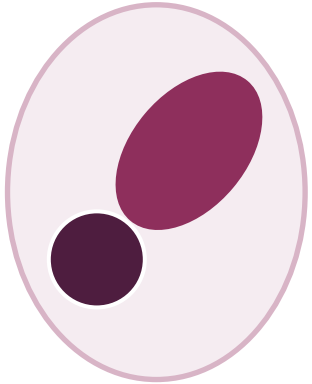
Letak sungsang

Memanjang; bokong di bawah



Letak lintang

Sumbu tegak lurus; presentasi bahu



Letak oblik

Sumbu menyilang; kepala di fosa iliaka

Unstable lie: letak janin yang terus berubah-ubah setelah 37 minggu

Mengapa 36 minggu menjadi batas penting

±25%
sungsang pada 28 minggu

±7%
sungsang pada 32 minggu

3–4%
sungsang saat aterm

Versi spontan jarang

Setelah 36 minggu, hanya sekitar 8% janin sungsang berputar sendiri.

Letak lintang lebih jarang

Sekitar 1 dari 300 kehamilan aterm, tetapi risikonya lebih besar.

Tiga jenis presentasi bokong

1

Bokong murni

Frank breech

Paha fleksi, lutut ekstensi; kaki berada dekat kepala. Tersering saat aterm.

2

Bokong sempurna

Complete breech

Paha dan lutut fleksi; kaki teraba di samping bokong.

3

Bokong kaki

Incomplete / footling

Satu atau dua kaki menjadi bagian terbawah. Risiko prolaps tali pusat tertinggi.

Jenis sungsang menentukan pilihan cara persalinan: pastikan dengan USG



a)



b)



c)

Kelainan letak janin set

2

Faktor risiko

Apa pun yang mengubah ruang gerak janin atau menghalangi kepala masuk panggul

Faktor risiko kelainan letak

Ibu dan uterus

- Multiparitas
- Kelainan bentuk uterus
- Mioma atau tumor pelvis
- Panggul sempit
- Riwayat sungsang

Janin

- Prematuritas
- Kehamilan ganda
- Hidrosefalus, anensefalus
- Pertumbuhan terhambat
- Kelainan neuromuskular

Plasenta dan ketuban

- Plasenta previa
- Polihidramnion
- Oligohidramnion
- Tali pusat pendek
- Implantasi di kornu

Kelainan letak yang menetap setelah 36 minggu: selalu cari penyebabnya

Empat mekanisme di balik faktor risiko

1

Ruang terlalu longgar

Janin bebas berputar: polihidramnion, multiparitas, prematuritas.

2

Ruang terlalu sempit

Janin tidak sempat berputar: oligohidramnion, kehamilan ganda, kelainan uterus.

3

Jalan bawah terhalang

Kepala tidak dapat masuk panggul: plasenta previa, mioma, panggul sempit.

4

Janin tidak dapat menyesuaikan

Bentuk atau gerak janin abnormal: hidrosefalus, kelainan neuromuskular.

3

Pemeriksaan

Anamnesis, pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan USG

Anamnesis: petunjuk dari keluhan ibu

- Gerakan janin lebih terasa di perut bagian bawah
- Rasa penuh atau benda keras di ulu hati
- Riwayat obstetri: paritas, sungsang, seksio sesarea
- Riwayat mioma, kelainan uterus, atau operasi uterus
- Perdarahan, ketuban pecah, atau tanda inpartu

Pastikan dulu

Usia kehamilan

Gunakan HPHT dan USG trimester pertama. Sebelum 36 minggu, sungsang masih sering berputar sendiri.

Pemeriksaan Leopold langkah demi langkah

I — II — III — IV

Leopold I

Apa yang ada di fundus?

Kepala: keras, bulat, melenting. Bokong: lunak, tidak melenting.

Leopold II

Di mana punggung janin?

Punggung: rata, memanjang. Bagian kecil di sisi berlawanan.

Leopold III

Apa bagian terbawah?

Kepala atau bokong, dan masih dapat digoyang atau tidak.

Leopold IV

Sudah masuk panggul?

Konvergen: belum masuk. Divergen: sudah masuk panggul.

Lengkapi dengan auskultasi: lokasi DJJ terjelas ikut membantu diagnosis.

Membedakan temuan pemeriksaan luar

Pemeriksaan	Presentasi kepala	Letak sungsang	Letak lintang
Fundus	Bokong: lunak, tidak melenting	Kepala: keras, bulat, melenting	Kosong
Sisi uterus	Punggung di satu sisi	Punggung di satu sisi	Kepala di satu sisi, bokong di sisi lain
Bagian bawah	Kepala	Bokong	Kosong
DJJ terjelas	Di bawah pusat	Setinggi atau di atas pusat	Di sekitar pusat
Bentuk uterus	Memanjang	Memanjang	Melebar, fundus rendah

Pemeriksaan dalam dan USG

Pemeriksaan dalam

- Hanya saat inpartu, setelah plasenta previa disingkirkan
- Sungsang: sakrum, tuber iskiadikum, anus, atau kaki
- Lintang: bahu, iga, atau lengan menumbung
- Selalu cari tali pusat di depan bagian terbawah

USG: pemeriksaan pemasti

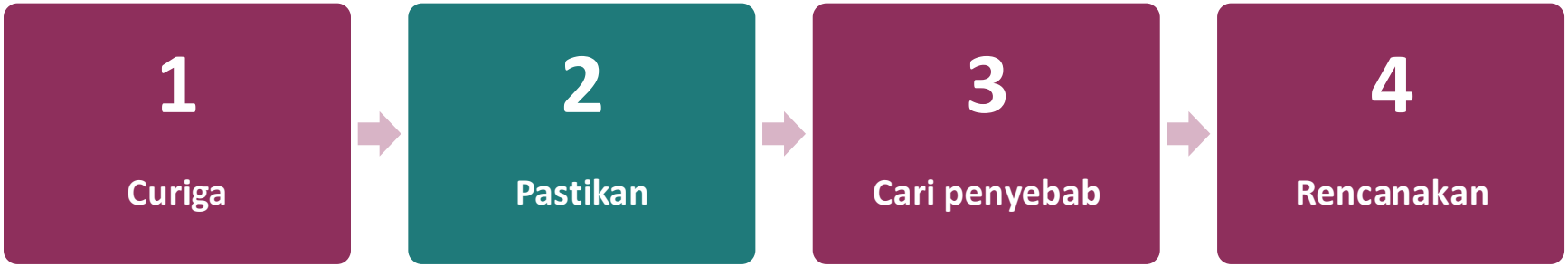
- Letak, presentasi, dan jenis sungsang
- Sikap kepala: fleksi atau hiperekstensi
- Taksiran berat janin
- Lokasi plasenta dan jumlah ketuban
- Kelainan janin, jumlah janin, tumor pelvis

4

Menegakkan diagnosis

Dari kecurigaan klinis sampai rumusan diagnosis yang lengkap

Alur menegakkan diagnosis



Leopold dan DJJ pada setiap ANC sejak 36 minggu

USG: letak, presentasi, dan jenis sungsang

Plasenta previa, mioma, gemelli, kelainan janin, ketuban

Nilai kelayakan versi luar dan cara persalinan; rujuk

Kelainan letak adalah temuan; diagnosis belum lengkap sebelum penyebabnya dicari.

5

Tatalaksana

Versi luar, pilihan cara persalinan, letak lintang, dan kegawatan

Sungsang setelah 36 minggu: alur keputusan

Sungsang terkonfirmasi USG, 36 minggu atau lebih

Tawarkan versi luar bila tidak ada kontraindikasi

Berhasil
Presentasi kepala: persalinan pervaginam

Gagal, kontraindikasi, atau ibu menolak

Konseling dua pilihan:

- Seksio sesarea elektif setelah 39 minggu
- Pervaginam terencana pada kasus terpilih

Versi luar: kapan dan bagaimana

±50%

keberhasilan versi luar

40% nulipara · 60% multipara

RCOG Green-top Guideline 20a, 2017

Waktu

Mulai 36 minggu pada nulipara, 37 minggu pada multipara

Tempat

Fasilitas yang siap seksio sesarea darurat

Pemantauan

Kardiotokografi sebelum dan sesudah tindakan

Penunjang

Tokolitik beta-mimetik; anti-D bila Rhesus negatif

Versi luar: kontraindikasi dan risiko

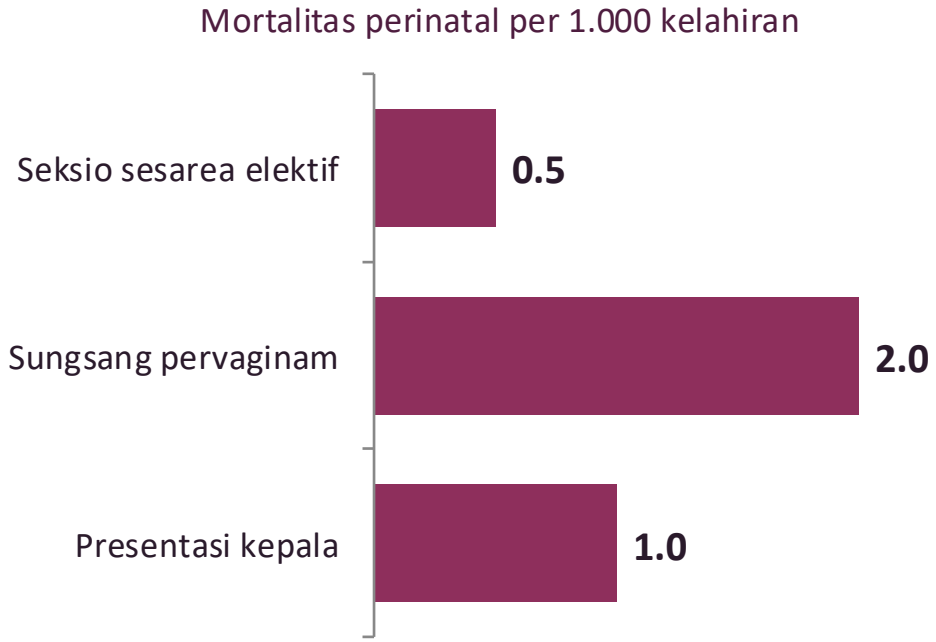
Jangan dilakukan bila

- Ada indikasi seksio sesarea lain, misalnya plasenta previa
- Solusio plasenta atau perdarahan dalam 7 hari
- Kardiotokografi abnormal
- Ketuban sudah pecah
- Kehamilan ganda

Risiko untuk konseling

- Bradikardia janin sementara
- Solusio plasenta (jarang)
- Perdarahan fetomaternal
- Seksio sesarea darurat sekitar 0,5% dalam 24 jam
- Rasa nyeri selama tindakan

Cara persalinan sungsang: angka konseling



1. Seksio sesarea elektif sedikit menurunkan mortalitas perinatal.
2. Namun menambah risiko ibu saat ini dan pada kehamilan berikutnya.
3. Seleksi kasus dan penolong terampil membuat persalinan pervaginam lebih aman.

Sumber: RCOG Green-top Guideline 20b, 2017

Sungsang pervaginam: seleksi kasus

Dapat dipertimbangkan

- Bokong murni atau bokong sempurna
- Kepala janin dalam sikap fleksi
- Taksiran berat janin sesuai
- Penolong terlatih hadir
- Seksio sesarea dapat segera dilakukan

Tidak dianjurkan

- Presentasi kaki (footling)
- Kepala hiperekstensi pada USG
- Taksiran berat lebih dari 3.800 g
- Berat janin di bawah persentil 10
- Tanda gangguan janin antenatal

Prinsip pertolongan persalinan sungsang

1

Bokong sampai pusat

Jangan menarik. Biarkan lahir spontan dan kendurkan tali pusat.

2

Bahu dan lengan

Bila macet: perasat klasik, Mueller, atau Løvset.

3

Kepala menyusul

Mauriceau-Smellie-Veit atau forseps Piper; jaga kepala tetap fleksi.

Prinsip utama: tangan penolong menunggu, bukan menarik

Letak lintang, oblik, dan unstable lie

Sebelum inpartu

- USG: cari plasenta previa, tumor, polihidramnion
- Versi luar dapat dicoba
- Pertimbangkan rawat inap sejak 37 minggu
- Bila menetap: seksio sesarea elektif sekitar 39 minggu

Saat inpartu atau ketuban pecah

- Periksa dalam: singkirkan prolaps tali pusat
- Janin aterm hidup letak lintang: seksio sesarea



Bahaya utama

- Prolaps tali pusat
- Lengan menumbung
- Letak lintang kasep
- Ruptur uteri

Kegawatan: prolaps tali pusat

1. Panggil bantuan dan siapkan seksio sesarea atau rujukan segera
2. Posisikan ibu knee-chest atau Trendelenburg
3. Dorong bagian terbawah janin ke atas dengan jari
4. Isi kandung kemih 500–750 mL bila tindakan tertunda
5. Hindari memegang tali pusat berlebihan; pantau DJJ

Kapan harus waspada

- Letak lintang atau oblik
- Presentasi kaki
- Ketuban pecah saat bagian terbawah masih tinggi
- Polihidramnion

Peran dokter di layanan primer

Lakukan

- Leopold dan DJJ pada setiap ANC sejak 36 minggu
- Konfirmasi dengan USG bila tersedia
- Edukasi: ketuban pecah atau mulas, segera ke rumah sakit
- Rujuk terencana ke SpOG sebelum inpartu

Hindari

- Versi luar di fasilitas tanpa kesiapan seksio sesarea
- Induksi atau drip oksitosin
- Menunggu inpartu baru merujuk
- Menarik janin saat menolong sungsang

Pesan kunci

1. Setelah 36 minggu kelainan letak jarang berubah sendiri: pastikan dan rencanakan.
2. Selalu cari penyebab: plasenta previa, mioma, kehamilan ganda, kelainan janin.
3. Leopold untuk mencurigai, USG untuk memastikan.
4. Sungsang: tawarkan versi luar; bila gagal, konseling cara persalinan.
5. Lintang yang menetap: seksio sesarea, dan waspadai prolaps tali pusat.

Referensi

1. Impey LWM, et al. External Cephalic Version and Reducing the Incidence of Term Breech Presentation. RCOG Green-top Guideline No. 20a. BJOG 2017.
2. Impey LWM, et al. Management of Breech Presentation. RCOG Green-top Guideline No. 20b. BJOG 2017.
3. RCOG. Umbilical Cord Prolapse. Green-top Guideline No. 50. 2014.
4. ACOG. External Cephalic Version. Practice Bulletin No. 221. Obstet Gynecol 2020.
5. ACOG. Mode of Term Singleton Breech Delivery. Committee Opinion No. 745. Obstet Gynecol 2018.
6. Hannah ME, et al. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term. Lancet 2000;356:1375–83.
7. Cunningham FG, et al. Williams Obstetrics, edisi 26. McGraw-Hill; 2022.
8. Prawirohardjo S. Ilmu Kebidanan, edisi 4. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.